



Genetik

Critical Mass x OG Kush



Geruch

erdig, süß



Geschmack

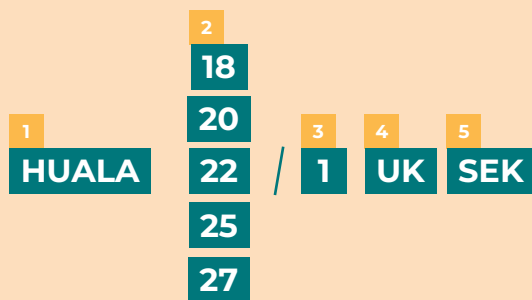
erdig, süß



Wirkung

analgetisch^{1,2,3}, antiinflammatorisch^{4,5}, anxiolytisch⁶, antidepressiv⁶

Produktname



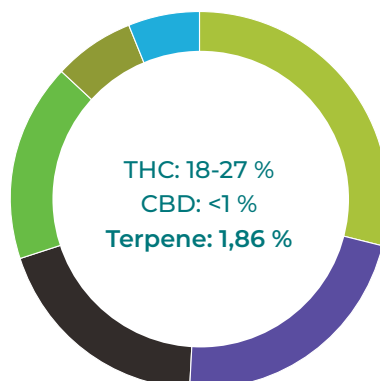
- 1 Eigenmarke
- 2 THC SOLL
- 3 CBD SOLL
- 4 Herkunft
- 5 Kultivar

Details zu Spiced Earth Kush

Spiced Earth Kush ist ein Indica-dominanter Hybridkultivar, der zwei etablierte Klassiker der Cannabisgenetik vereint: Critical Mass von Shantibaba (Mr. Nice Seedbank) und den US-amerikanischen Kultivar OG Kush.

Diese genetische Kombination steht für Stabilität, gleichmäßige Blütenentwicklung und ein klar definiertes Terpenprofil. Das Ergebnis ist eine medizinische Cannabisblüte mit einem erdig-süßen Geruchsbild, das sich auch im Geschmack deutlich widerspiegelt und eine konsistente sensorische Wahrnehmung ermöglicht – ein relevanter Faktor für Patient:innen in einer kontinuierlichen Therapie.

- 29 % β -Caryophyllen
- 22 % Myrcen
- 17 % Delta-Limonen
- 7 % Alpha-Humulen
- 6 % Linalool
- 19 % Sonstige



Terpene

Die dominantesten Terpene der Sorte - teilweise ausschlaggebend für den Geschmack, die Wirkung & den Geruch. Mehr Infos zu Terpenen finden Sie auf dem Datenblatt über Terpene und ihre Wirkung.

Prozentualer Anteil am Gesamtterpengehalt.
Prozentangaben sind Mittelwerte über mehrere Chargen.



Dosierungsbeispiel

Beginn mit einer niedrigen Dosis und langsamen Steigerungen, bis die gewünschte Wirkung erreicht ist.

Standard-Anfangsdosis: 25-50 mg Cannabisblüte pro Tag (ca. 6,25–12,5 mg THC bei 25 % THC)^A

Unerfahrene Patienten: 10 mg Cannabisblüte pro Tag (ca. 2,5 mg THC bei 25 % THC)^B

Produktvariationen

Produktname	PZN 5g	PZN 15g	PZN 100g
HUALA 18/1 UK SEK	20517099	20517024	20517001
HUALA 20/1 UK SEK	20516993	20516941	20517030
HUALA 22/1 UK SEK	20517082	20516935	20516964
HUALA 25/1 UK SEK	20517018	20516958	20517107
HUALA 27/1 UK SEK	20517047	20517136	20517053

Rezeptanforderungen

- Bei Cannabis muss die **exakte** Produktbezeichnung analog der Herstellervorgabe auf dem Rezept angegeben werden.
- Weiterhin muss die **exakte** patientenindividuelle Zubereitung und Dosierung mit aufgenommen werden.

Quellennachweise

¹Klaue AL, Racz I, Pradier B, Markert A, Zimmer AM, Gertsch J, Zimmer A. The cannabinoid CB₂ receptor-selective phytocannabinoid beta-caryophyllene exerts analgesic effects in mouse models of inflammatory and neuropathic pain. Eur Neuropsychopharmacol. 2014 Apr;24(4):608-20. doi: 10.1016/j.euroneuro.2013.10.008. Epub 2013 Oct 22. PMID: 24210682.

²Katsuyama S, Mizoguchi H, Kuwahata H, Komatsu T, Nagaoka K, Nakamura H, Bagetta G, Sakurada T, Sakurada S. Involvement of peripheral cannabinoid and opioid receptors in beta-caryophyllene-induced antinociception. Eur J Pain. 2013 May;17(5):664-75. doi: 10.1002/j.1532-2149.2012.00242.x. Epub 2012 Nov 9. PMID: 23138934.

³Fidyk K, Fiedorowicz A, Strzdała L, Szumny A. beta-caryophyllene and beta-caryophyllene oxide-natural compounds of anticancer and analgesic properties. Cancer Med. 2016 Oct;5(10):3007-3017. doi: 10.1002/cam4.816. Epub 2016 Sep 30. PMID: 27696789; PMCID: PMC5083753.

⁴Irrera N, D'Ascola A, Pallio G, Bitto A, Mazzon E, Mannino F, Squadrone V, Arcoraci V, Minutoli L, Campo GM, Avenoso A, Bongiorno EB, Vaccaro M, Squadrone F, Altavilla D. beta-caryophyllene Mitigates Collagen Antibody Induced Arthritis (CAIA) in Mice Through a Cross-Talk between CB2 and PPAR-γ Receptors. Biomolecules. 2019 Jul 31;9(8):326. doi: 10.3390/biom9080326. PMID: 31370242; PMCID: PMC6723248.

⁵Baradaran Rahimi V, Askari VR. A mechanistic review on immunomodulatory effects of selective type two cannabinoid receptor beta-caryophyllene. Biofactors. 2022 Jul;48(4):857-882. doi: 10.1002/biof.1869. Epub 2022 Jun 1. PMID: 35648433.

⁶Bahi A, Al Mansouri S, Al Memari E, Al Ameri M, Nurulain SM, Ojha S. β-Caryophyllene, a CB2 receptor agonist produces multiple behavioral changes relevant to anxiety and depression in mice. Physiol Behav. 2014 Aug;135:119-24. doi: 10.1016/j.physbeh.2014.06.003.

^AMüller-Vahl K, Grotenhermen F. Medizinisches Cannabis: Die wichtigsten Änderungen. Deutsch Ärztebl. International 2017

^BHorlemann J, Schürmann N. DGS-Praxisleitlinie Cannabis in der Schmerzmedizin. Version: 1.0 für Fachkreise. Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. 2018

Die angegebenen medizinischen Wirkungen beziehen sich auf mögliche Effekte des dominantesten Terpens in der Blüte. Die Angaben sind lediglich ein Anhaltspunkt für die passende Produktauswahl durch das medizinische Fachpersonal und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.